Lignes directrices pour les essais cliniques au Cameroun

Contenu

AVANT-PROPOS 3
COMITÉ DE VALIDATION 6
LISTE DES ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 7
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS 8
Section 1 : Introduction 8
Section 2 : Portée de ces lignes directrices 8
Section 3 : Termes et définitions [1] 9
CHAPITRE II : PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE DES ESSAIS CLINIQUES 14
Section 1 : Rappel sur les essais cliniques 14
Section 2 : Exigences générales [4] 16
Section 3 : Exigences particulières 24
Section 4 : Qualifications des enquêteurs 28
Section 5 : Produit de recherche 29
Section 6 : Gestion des échantillons biologiques 31
Section 7 : Modèles d'évaluation des protocoles d'essais cliniques 32
Section 8 : Éléments de refus d'habilitation éthique ou d'autorisation administrative de recherche 34
Article 9 : Recours en cas d'avis défavorable 35
Section 10 : Surveillance et inspection des essais cliniques 35
Section 11 : Déclaration des événements indésirables liés aux produits de santé 36
Section 12 : Rapports d'essais cliniques fournis par le chercheur principal 36
Section 13 : Exigences particulières pour les essais cliniques de médecines traditionnelles améliorées (MTA) 37

AVANT-PROPOS

La recherche clinique vise à améliorer la santé humaine et à accroître notre compréhension de la biologie humaine, ce qui conduit finalement à des avancées significatives dans les connaissances scientifiques. Les essais cliniques sont essentiels au développement de nouveaux médicaments et de nouvelles techniques d'administration, de traitement et de diagnostic des médicaments. Il contribue ainsi à optimiser la prise en charge des cas et par conséquent, la performance du système de santé. Cependant, cela doit se faire dans le respect des règles d'éthique et de protection des participants.

La loi n° 2022/008 du 27 avril 2022 relative à « la recherche médicale impliquant la personne humaine au Cameroun », promulguée par le Président de la République, a achevé le processus d'encadrement de la recherche en santé humaine au Cameroun entamé depuis 2002.

Même si de réels progrès ont été réalisés dans le développement de la réglementation de la recherche en santé humaine, il est nécessaire de mettre en place des lignes directrices pour garantir une protection efficace des participants à la recherche clinique.

Ce guide intitulé « Lignes directrices pour les essais cliniques au Cameroun » est un outil de travail essentiel mis à la disposition de tous les acteurs impliqués dans la recherche en santé humaine, pour leur permettre de réaliser leurs projets conformément aux meilleures pratiques cliniques et selon les directives internationales reconnues.

A cette fin, je vous invite à vous l'approprier et à en faire bon usage au bénéfice de la politique de recherche clinique ainsi que des bénéficiaires des conclusions desdites recherches.

MERCI

Nous tenons à remercier nos partenaires : European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), Meilleur Accès aux Soins de Santé (MA SANTE), Medical Research, Regulatory Affairs and Public Health Consulting Services for Africa (MEDRAC Africa), Elizabeth Glaser Pediatric. Fondation SIDA (EGPAF) ; Organisation de Coordination de Lutte contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC) et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), comité de rédaction et comité de validation pour leur précieuse collaboration et leur soutien constant tout au long de la rédaction, de la relecture, de la traduction et de la validation de cet important guide de procédure intitulé : « LIGNES DIRECTRICES POUR LES ESSAIS CLINIQUES AU CAMEROUN ».

COMITÉ DE VALIDATION

Pr. ZOUNG-KANYI BISSEK Anne Cécile	C/DROS
Dr YABA DANA Basilic	DPML
Dr SALIHOU SADOU	DG CENAME
Pr. ATEUDJIEU Jérôme	C/CRC DROS
Dr ATEBA Ulysse	MEDRAC Afrique
Dr DJITAFO-FAH Aimé	OCEAC
Prof. FOKUNANG Charles	Université de Yaoundé I/FMSB
Pr. NGABA- MAMBO Olive Nicole	C/CRSPE
Dr ABONG Thérèse	Président par intérim du CNERSFI
Dr ONG NYEKI MOUAHA-BELL Adèle-Rose	Université de Yaoundé I/FMSB
M. YOPNDOI Charles	Chef de l'unité Suivi/MINSANTE
M. OBAM Nicolas Michel	CEA1/CRSPE
Mme NAAH Félicité	CEA2/CRSPE
M. ATANGA Benjamin	Cadre/DROS
M. NGU PAULNembo	Cadre/DROS
Dr MOULIOM Fatima	Cadre/DROS
Dr PALISSON Tatiana	Cadre/DROS
Mme ZOBO Marie Charlotte	Cadre/DROS
Mme BAKARI BAKARI Madeleine	Cadre/DROS
M. NGUEMKAM Gildas	Informaticien/DROS
MmeTEH CANAPE MONTEFI Caroline	Cadre/DROS
M. NDIE Justin	Cadre/DROS
Mme YIMDJO SIMO	Cadre/DROS

Mme MABOMA Odette	Traduction Cellulaire/MINSANTE

COMITÉ DE VALIDATION

Pr. NJOCK Louis Richard	SG/M INSANTE
Dr KOUAKAP Solange	IGSPL
Dr SALIHOU SADOU	DPML
Pr. ZOUNG-KANYI BISSEK Anne Cécile	C/DROS
Dr YABA DANA Basile	DPML
Professeur Joseph KAMGNO	FMSB-UYI
Professeur MBANYA Jean Claude	FMSB-UYI
Pr. NGABA- MAMBO Olive Nicole	C/CRSPE-DROS
Dr DJITAFO-FAH Aimé	OCEAC
Professeur OKOMO ASSOUMOU Marie Claire	SP/CNERSH
Dr ABONG Thérèse	VP/CNERSH
Dr Ulysse ATEBA NGOA	MEDRAC-Afrique
Pr. ATEUDJ1EU Jérôme	C/CRC DROS
M. YOPNDOI Charles	C/Suivi
Mme NGUJOAmelia Nicole	CEL/TRAD
Pr NGABA MAMBO Olive	CRSPE/DROS
Monsieur MPAH Julien	CR/DAJC
Mme MEUNGUI Yvette	CEA1/DAJC
Mme NAAH Félicité	CEA2/CRSPE-DROS
Dr MOULIOM Fatima	Cadre/DROS
Dr PALISSON Tatiana	Cadre/DROS
M. NDIE Justin	Cadre/DROS
M. ATANGA Benjamin	Cadre/DROS
Mme TEH MONTEH CANAPE Caroline	Cadre/DROS

LISTE DES ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

RAA	Autorisation administrative de recherche
AMM	Autorisation de marketing
ANRPh	Autorité nationale de réglementation pharmaceutique
AVEZ-VOUS	Autorisation temporaire d'utilisation
PCB	Bonnes pratiques cliniques
BPF	Bonnes pratiques de fabrication
CIOMS	Lignes directrices éthiques internationales pour la recherche en santé impliquant des participants humains
CNERSH	Comité national d'éthique de la recherche pour la santé humaine
DROS	Division de Recherche Opérationnelle en Santé
PCI	Conférence internationale sur l'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain
IGSPL	Inspection Générale des Services et Laboratoires Pharmaceutiques
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
MTA	Médecine traditionnelle améliorée
DPML	Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires
MON	Procédure d'opération standard

CHAPITRE I : GÉNÉRAL

Section 1 : Introduction

Les « Lignes directrices pour les essais cliniques au Cameroun » visent à garantir que les essais cliniques menés au Cameroun sont conçus et menés selon la rigueur scientifique et les normes éthiques conformément aux Bonnes Pratiques Cliniques [1, 2]. Le respect des exigences contenues dans ces lignes directrices donne au public l'assurance que les droits, la sécurité et le bien-être des participants aux essais cliniques sont protégés.

Section 2 : Portée de ces lignes directrices

Ces lignes directrices :

(1) Établir les exigences légales pour l'autorisation et la conduite d'essais cliniques telles que définies dans la loi-cadre dans le domaine de la santé [3] et la loi relative à la recherche médicale impliquant des êtres humains [4].

(2) S'appliquer à toutes les phases des essais cliniques relatifs aux médicaments et vaccins, aux équipements médicaux, aux produits de santé, au développement de procédures préventives, diagnostiques et thérapeutiques visant à améliorer la santé humaine.

(3) Destiné aux chercheurs, à l'industrie pharmaceutique, aux organismes de recherche clinique et aux promoteurs d'essais cliniques, que ce soit à des fins académiques ou de génération de données, destinés à figurer dans leur futur dossier de demande d'AMM (AMM) [5].

(4) Fournir des exigences spécifiques pour les essais cliniques de médecines traditionnelles améliorées [6].

Section 3 : Termes et définitions [1]

Autorisation administrative de recherche (AAR) [7] : Accord préalable délivré par le Ministère de la Santé pour permettre à un chercheur de démarrer effectivement ses recherches dans le domaine, après que ce dernier ait obtenu l'autorisation éthique du Comité National d'Éthique de la Recherche en Santé Humaine (CNERSH) .

Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique (NPRA) : La NPRA est créée par la Décision n°0732 du 19 juin 2017 [8]. Elle est chargée de coordonner et de contrôler le secteur pharmaceutique afin de préserver la santé publique. Le NPRA est composé des structures suivantes :

- L'inspection générale des services et laboratoires pharmaceutiques ;
- La gestion de la pharmacie, des médicaments et des laboratoires ;
- Le laboratoire national de contrôle de qualité et d'expertise des médicaments ;
- Le service de santé familiale ;
- Le pôle recherche opérationnelle en santé.

Piste Clinique : Toute étude systématique d'une intervention chez un volontaire, malade ou sain, qui comprend, entre autres, les médicaments et autres produits biologiques, les actes chirurgicaux, les techniques radiologiques, les appareils, les thérapies comportementales, les modifications des protocoles de soins, les soins préventifs, en afin d'évaluer les effets de ces interventions sur la santé.

Essai multicentrique : Essai clinique réalisé selon un protocole unique dans plusieurs lieux différents et donc par plus d'un chercheur.

Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) : Norme concernant la conception, la conduite, l'efficacité, le suivi et la vérification des essais cliniques ainsi que l'enregistrement,

[1] Les termes définis dans ces lignes directrices proviennent principalement des Lignes directrices de bonnes pratiques cliniques : addendum intégré à l'ICH E6(R2), et de la loi relative à la recherche médicale impliquant des êtres humains au Cameroun. les définitions prendront de facto le sens de toute mise à jour consécutive de l'ICH E6 (R2) et de la loi sur la recherche médicale, le cas échéant.

analyse et présentation des données associées et qui garantit la fiabilité et l'exactitude des données et des résultats présentés ainsi que la protection des droits, de l'intégrité et de l'identité des sujets.

Brochure Investigateur : Document mis à disposition de l'investigateur par le promoteur et contenant toutes les informations cliniques et non cliniques relatives au produit à tester lors de l'essai clinique, ainsi que des conseils pour assurer la prise en charge clinique des participants du sujet à cet essai. .

Apurement éthique : Avis rendu par le Comité d'Éthique, après son approbation de la validité scientifique et du respect des principes éthiques du protocole de recherche soumis par le promoteur ou l'investigateur.

Données personnelles liées à la santé : Toute information concernant une personne identifiée (données nominatives) ou identifiable (données codées ou pseudonymisées) ayant un lien avec son état de santé ou sa maladie, y compris les données génétiques.

Comité de sécurité et de suivi des données (Comité indépendant de suivi des données, Comité de suivi, Comité de suivi des données) : Comité de sécurité et de suivi des données qui peut être institué par le promoteur et chargé, d'une part, d'évaluer périodiquement l'avancement d'un essai clinique, le les données de sécurité et les résultats critiques concernant l'efficacité et, d'autre

part, de formuler des recommandations concernant la poursuite, la modification ou l'interruption d'un essai.

Confidentialité : Non-divulgation, à des personnes autres que les personnes autorisées, d'informations exclusives au promoteur ou de l'identité d'un sujet.

Consentement éclairé : Processus par lequel un sujet confirme volontairement sa volonté de participer à un essai particulier, après avoir été informé de tous les aspects de l'essai pouvant influencer sa décision. Le consentement éclairé est enregistré sur un formulaire écrit, signé et daté.

Effet indésirable à un produit médical : Toute réaction nocive ou inattendue provoquée par une dose quelconque d'un produit médical (voir les lignes directrices pour la gestion des données cliniques sur la sécurité des médicaments [9]).

Incident thérapeutique : Toute manifestation fâcheuse d'ordre médical chez un patient ou un sujet d'étude clinique auquel un produit pharmaceutique a été administré et qui n'a pas nécessairement de lien causal avec le traitement.

Incident thérapeutique grave ou effet (réaction) indésirable grave à un médicament : Tout événement médical indésirable survenu au cours de l'essai clinique qui, quelle que soit la dose du médicament, répond à au moins un des critères ci-dessous :

- entraîne la mort du sujet ;
- menace la vie;
- nécessite l'hospitalisation du patient ou la prolongation de son hospitalisation ;
- provoque un handicap ou une incapacité persistante ou marquée ;
- se manifeste par une anomalie ou une malformation congénitale.

Éthique de la recherche : Ensemble de règles morales, éthiques et comportementales qui s'appliquent à toute personne menant des activités de recherche [10].

Inspection : Examen officiel effectué par un organisme de réglementation des documents, des installations, des dossiers et de toute autre ressource que l'organisme de réglementation juge pertinente pour l'essai clinique et qui peuvent se trouver sur le site de l'essai, dans les installations du promoteur ou de l'organisme de recherche sous contrat (CRO). , ou tout autre établissement jugé approprié par l'organisme de réglementation.

Investigateur : Toute personne responsable de la conduite scientifique d'un projet de recherche en santé humaine.

Chercheur principal : le chercheur responsable d'une équipe de chercheurs et de la conduite globale d'un projet de recherche médicale sur un ou plusieurs sites désignés.

Site d'essai : L'endroit où se déroulent les activités liées à l'essai.

Modification (amendement) au protocole : Description écrite d'une modification ou d'une clarification officielle apportée au protocole.

Produit de recherche : forme pharmaceutique d'un ingrédient actif (médicament), d'une intervention ou d'un placebo testé ou utilisé comme produit de référence dans un essai clinique. Il comprend également un produit dont la commercialisation a été autorisée et qui est utilisé (formulé ou conditionné) d'une manière autre que la forme approuvée ou pour des indications non approuvées, ou pour collecter des données supplémentaires concernant une utilisation approuvée **.**

Promoteur : Personne physique ou morale chargée du lancement, de la gestion et du financement d'un essai clinique.

Promoteur-investigateur : Personne qui met en œuvre et réalise, seule ou avec d'autres, un essai clinique, et sous la responsabilité directe de laquelle le produit de la recherche est administré à un sujet. Le terme est réservé à une personne réelle (par exemple, il ne s'applique pas à une société ou à une organisation). Les obligations d'un promoteur-investigateur sont à la fois celles d'un promoteur et celles d'un enquêteur.

Protocole de recherche : Document daté, approuvé par le promoteur et par l'investigateur qui intègre les modifications successives et décrit la justification, les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques, l'organisation de la recherche, ainsi que les questions éthiques, le financement et les affiliations institutionnelles.

Rapport d'essai clinique : La description écrite d'un essai mené sur des sujets humains et portant sur un agent thérapeutique, prophylactique ou diagnostique, est intégrée pour former un rapport unique : la description, la présentation et l'analyse des données cliniques et statistiques [11].

Matériel biologique : Substances humaines provenant de personnes vivantes ou décédées, de fœtus ou d'embryons ; ou des animaux.

Représentant légal : Personne physique ou morale autorisée par la loi applicable à consentir, au nom d'un sujet potentiel, à la participation de ce dernier à l'essai clinique.

Sujet/sujet participant à l'essai : Personne qui participe à un essai clinique, que ce soit dans le groupe expérimental ou dans le groupe témoin.

Placebo : Substance inactive administrée à certains participants à une étude dans le but de comparer les effets avec ceux des participants ayant reçu le produit utilisé.

Traitement standard (de référence) : Médicament ou intervention approuvé par une autorité compétente pour une indication spécifique.

Sujets vulnérables : Individus dont le désir de participer à un essai clinique peut être indûment influencé par l'espoir, justifié ou non, de bénéficier d'avantages liés à leur participation ou par la crainte de représailles de la part de membres plus influents d'une structure hiérarchique en cas de refus. Les exemples incluent les membres d'un groupe avec une structure hiérarchique, tels que les étudiants en médecine, en pharmacologie, en médecine dentaire et en soins infirmiers, les jeunes employés d'hôpitaux ou de laboratoires, les membres de l'industrie pharmaceutique, les membres des forces armées et les prisonniers. Les patients atteints de maladies incurables, les personnes vivant dans des maisons de retraite, les chômeurs ou les personnes pauvres, les patients confrontés à une urgence, les membres de minorités ethniques, les sans-abri, les nomades, les réfugiés, les mineurs et les personnes incapables de donner leur consentement sont également des sujets vulnérables.

Surveillance : Activité qui consiste à suivre l'évolution d'un essai clinique et à s'assurer que cet essai est réalisé conformément au protocole, aux procédures opératoires standard (POS), aux bonnes pratiques cliniques (BPC) et aux exigences réglementaires applicables, et que les données associées est enregistrée et présentée conformément à ces mêmes directives.

CHAPITRE II : PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE DES ESSAIS CLINIQUES

Section 1 : Rappel sur les essais cliniques

Les essais cliniques sont classés en 4 phases (phases I à IV). Une brève description non exhaustive des différentes phases est donnée ci-dessous [12].

(1) Phase I

Objectif : Réaliser une évaluation préliminaire de la sécurité du principe actif, de son profil pharmacocinétique et, si possible, de sa pharmacodynamie chez l'homme.

Caractéristiques : Il s'agit de la première administration à l'homme d'un principe actif validé en phase préclinique. Souvent réalisé chez des volontaires sains auxquels sont administrées des doses réduites dudit principe actif.

(2) Phase II

Objectifs : Démontrer l'existence d'une activité thérapeutique et évaluer la sécurité à court terme du principe actif.

Caractéristiques : A lieu sur des sujets souffrant ou exposés à une maladie ou une affection pour laquelle le principe actif doit être indiqué. Cette phase vise également à déterminer la posologie ou les schémas thérapeutiques appropriés et (si possible) à clarifier les relations dose-réponse.

(3) Phase III

Objectifs : Déterminer l'efficacité du principe actif ou de l'intervention en le comparant à d'autres traitements standards et/ou expérimentaux. Ces études permettent également de caractériser davantage le profil de tout effet indésirable courant et les caractéristiques particulières du produit (par exemple, interactions médicamenteuses cliniquement pertinentes, facteurs conduisant à des différences d'effet tels que l'âge) ou de l'intervention.

Caractéristiques : De préférence être conçu comme des essais randomisés en double aveugle, mais d'autres types d'études peuvent être acceptables. D'une manière générale, les conditions dans lesquelles sont réalisés ces tests doivent être les plus proches possibles des conditions normales d'utilisation du principe actif ou de l'intervention.

(4) **Phase IV**

Objectifs : déterminer les effets indésirables à long terme et mesurer l'efficacité d'un médicament ou d'une intervention dans des conditions réelles d'utilisation en population générale.

Caractéristiques : études réalisées après commercialisation du produit (post-AMM) prenant en compte les indications pour lesquelles le produit a été agréé. Ces études doivent utiliser les mêmes normes scientifiques et éthiques que celles appliquées dans les études de phase I à III.

Nota Bene : une fois qu'un produit de recherche a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) au Cameroun, toute étude le concernant et visant à explorer de nouvelles indications, dosages, modes d'administration, associations, etc., sera considérée et traitée comme un essai clinique.

Section 2 : Exigences générales [4]

(1) L'essai clinique d'un produit de recherche ne peut être réalisé sur des êtres humains que si et pour autant que :

- Les risques et inconvénients potentiels prévisibles sont médicalement justifiables et n'excèdent pas les bénéfices attendus pour le sujet participant à l'essai clinique ;
- L'importance attendue du produit de la recherche pour la science et la médecine est avérée ;
- selon l'état des connaissances scientifiques, il est prouvé que l'essai clinique, lorsqu'il concerne un produit de recherche correspondant à un organisme génétiquement modifié ou à une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, ne doit pas induire d'effets nocifs injustifiés sur la santé de tiers. les partis et l'environnement;
- le participant à l'essai clinique, s'il est adulte, a été informé de la nature, de l'importance et des implications de l'essai clinique et a donné son consentement éclairé écrit et volontaire, ce qui implique que :
    i. le participant à l'essai ou le témoin et/ou le représentant légal, le cas échéant, est informé par l'enquêteur principal, ou une personne qualifiée désignée par l'enquêteur principal ;

ii. la procédure de consentement éclairé est réalisée selon les règles de Bonnes Pratiques Cliniques ;

iii. le consentement donné par le participant au procès, ou le témoin et/ou son représentant légal, le cas échéant, est documenté par écrit, daté et signé par chacune des personnes concernées ;

iv. si le sujet participant à l'essai est incapable de lire ou d'écrire le français ou l'anglais, le consentement éclairé est obtenu en présence d'au moins un témoin alphabétisé, parlant la langue de ce dernier, mais ne faisant pas partie de l'équipe d'étude. Dans ce cas, le formulaire de consentement doit contenir l'empreinte digitale du participant à l'essai pour signifier son approbation de participer à l'essai clinique. La participation du témoin alphabétisé au processus d'obtention du consentement doit être documentée par écrit et le formulaire de consentement doit recueillir la signature du témoin.

v. le sujet participant à l'essai est informé de la finalité de la collecte et de l'utilisation de ses données personnelles, notamment médicales ; le participant à l'essai sera notamment informé du fait que, le cas échéant, les données collectées seront transmises au promoteur et aux services compétents du Ministère de la Santé Publique sans révéler l'identité du participant à l'essai et seront mises à disposition lors de toute inspection du site d'essai ;

- l'utilisation du produit expérimental est indiquée conformément aux données et découvertes scientifiques récentes et vise à prévenir l'apparition d'une maladie ou à sauver la vie de la personne malade, à rétablir sa santé, à soulager ses souffrances, ou

- ce médicament une fois développé doit bénéficier directement au groupe de patients souffrant de la même maladie que le sujet participant à l'essai.

(2) Tout essai clinique doit avoir un « sponsor », à savoir une personne morale ou physique chargée de son lancement et de sa gestion. Cette « responsabilité simple » est à distinguer des questions liées à la « responsabilité civile et pénale » relatives aux dommages subis par les patients. Le régime de responsabilité civile et pénale applicable dépend des lois nationales en la matière.

(3) Le promoteur, l'investigateur et toutes les autres personnes impliquées dans la réalisation d'un essai clinique doivent, lors de sa réalisation, satisfaire :

- les exigences de bonnes pratiques cliniques telles que définies dans les lignes directrices actuelles de l'ICH [l] et dans les lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche en santé impliquant des participants humains [13] ;
- toute autre exigence jugée pertinente par le Ministère de la Santé du Cameroun.

(4) L'essai clinique ne peut être initié par le promoteur que si le Comité National d'Ethique de la Recherche en Santé Humaine (CNERSH) a délivré une autorisation éthique et que le Ministère en charge de la Santé Publique a délivré une Autorisation Administrative de Recherche. partant de la conclusion que les bénéfices thérapeutiques et de santé publique attendus sont supérieurs aux risques potentiellement encourus par les sujets de l'étude et la population. La conduite de cet essai clinique ne pourra être poursuivie que si le rapport bénéfice/risque reste favorable lors du suivi de l'essai.

(5) La demande d'habilitation éthique et la demande d'Autorisation Administrative de Recherche sont déposées respectivement auprès du Comité National d' Ethique de la Recherche pour la Santé Humaine et du Ministère en charge de la Santé Publique, la demande est signée par le promoteur et l'investigateur principal. Lorsque le chercheur principal ne dispose pas d'adresse institutionnelle et/ou

physique au Cameroun, la demande est signée par le promoteur et le chercheur résidant au Cameroun.

(6) La demande d'habilitation éthique et la demande d'Autorisation administrative de recherche doivent être faites séquentiellement sauf dans le cadre de situations dûment définies par le Ministère de la Santé Publique comme par exemple en cas d'urgence de Santé Publique.

(7) L'Autorisation administrative de recherche est valable pour la durée de l'étude précisée dans le protocole de recherche ou dans des cas particuliers pour une durée dûment définie par le Ministère chargé de la santé.

(8) L'habilitation éthique est valable pour une durée de deux (02) ans renouvelable, le cas échéant, l'habilitation éthique est valable pour la durée précisée par le Comité National d'Ethique [14],

(9) L'obtention de l'habilitation éthique est subordonnée au dépôt d'un dossier complet auprès du Comité national d'éthique de la recherche en santé humaine. Ce dossier comprend les documents suivants :

- une demande écrite en français ou en anglais, tamponnée au tarif en vigueur, signée par le chercheur principal national et adressée au Président de la Commission ;
- un protocole de recherche paginé rédigé soit en français, soit en anglais, signé par tous les enquêteurs, et présenté selon le plan défini par le CNERSH ;
- les annexes : notice d'information et formulaire de consentement rédigés en anglais et en français, outils de collecte de données, curriculum vitae daté et signé par le chercheur principal et les co-chercheurs de l'équipe de recherche ;
- les différentes autorisations éthiques le cas échéant ;
- l’accord du ou des responsables de la ou des structures de santé où seront réalisées les recherches ;

- une lettre d'engagement à rendre les résultats de la recherche accessibles à la population recherchée et à respecter toutes autres exigences prévues par la réglementation en vigueur ;
- une attestation de paiement des frais d'évaluation du protocole de recherche ;
- la notice d'information du produit expérimental ;
- une brochure de l'enquêteur ;
- une police d'assurance valide couvrant les dommages possibles aux sujets et aux enquêteurs ;
- lorsque le projet de recherche implique un transfert de matériel biologique et un échange de données collectées entre plusieurs institutions nationales ou internationales, le dossier comprend, outre les documents mentionnés ci-dessus :
    i. le contrat de transfert de données biologiques ou « Contrat de Transfert de Matériel » ;
    ii. l'accord de partage de données d'étude ou Data Sharing Agreement ;
- un plan de diffusion des résultats qui cible les participants à la recherche, les autorités sanitaires locales et nationales, le comité d'éthique concerné ainsi que les pairs scientifiques ;
- le budget relatif à la mise en œuvre du plan de diffusion.

(10) Le dossier de demande d'Autorisation Administrative de Recherche (AAR) déposé auprès du Ministère de la Santé Publique doit comprendre les pièces suivantes :

- une lettre de requête timbrée au tarif en vigueur adressée au Ministre chargé de la Santé Publique et comprenant la liste des documents présentés avec leurs numéros de version et leurs dates ;

- la liste de contrôle de demande d'AAR pour un essai clinique dûment complétée ;
- le protocole d'essai clinique daté et signé par l'investigateur principal, approuvé par le promoteur ou le promoteur, et comportant l'adresse de la personne physique ou morale qui soumet la demande (boîte postale, fax, téléphone, adresse email et siège de l'établissement ou de la recherche centre);
- la liste des sites d'essais cliniques prévus et le nombre de sujets à inclure sur les sites situés au Cameroun ;
- une description du ou des sites devant accueillir l'essai clinique au Cameroun indiquant leur adéquation à l'essai clinique concerné ;
- la fiche d'information du participant à la recherche, la procédure et le(s) formulaire(s) de consentement éclairé et le formulaire d'assentiment dans le cas où des mineurs doivent participer à l'essai clinique en français et en anglais ;
- la brochure de l'enquêteur ;
- des informations sur le produit de la recherche s'il bénéficie déjà d'une AMM ;
- Autorisation de mise sur le marché (pour les études de phase 4) ;
- le cas échéant, le résumé des essais cliniques antérieurs avec le(s) produit(s) médical(s) expérimental(s) ;
- le dossier du produit expérimental comprenant les données précliniques (le cas échéant) ;
- le cas échéant, des copies électroniques des principales publications évaluées par des pairs, conformément aux recommandations de l'ICMJE [15] ;
- la ou les copies des annonces de recrutement (le cas échéant) et des questionnaires ;
- le contenu de l'étiquetage des produits de la recherche ;

- informations sur le produit et certificat d'analyse pour les médicaments concomitants et les médicaments d'urgence ;
- la copie certifiée conforme du Certificat de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) délivré par l'autorité compétente du pays où le produit expérimental est fabriqué, traduite en anglais et/ou en français ;
- le(s) certificat(s) d'analyse du(des) produit(s) de recherche au Cameroun ;
- la déclaration sur l'honneur signée par l'investigateur principal attestant qu'il s'engage à respecter les BPC ainsi que les modalités de suivi du Ministère chargé de la Santé Publique et à fournir une restitution des travaux à la fin du projet ;
- le plan de diffusion des résultats des travaux ;
- l'accord préalable signé par le responsable de chaque structure/établissement de santé où l'étude sera mise en œuvre ;
- le Curriculum vitae daté et signé de chacun des chercheurs participant à la conduite de l'essai clinique (chercheur principal national, chercheurs principaux et/ou co-chercheurs, coordonnateur de l'étude, moniteur régional et local, affilié de recherche sous contrat, etc.) ;
- le budget signé entre le promoteur et le chercheur principal national ;
- la déclaration sur l'honneur signée par le(s) moniteur(s) pour respecter les BPC ainsi que les modalités de suivi du Ministère en charge de la Santé Publique ;
- la déclaration sur l'honneur signée par le promoteur/promoteur-investigateur de l'essai attestant qu'il connaît le protocole et qu'il se conformera aux bonnes pratiques cliniques déterminées par le

Ministère en charge de la Santé Publique dans la conduite de l'essai ;

- une preuve d'inscription de l'essai clinique dans un registre principal accessible en ligne ;
- la police d'assurance valable pendant la période de l'essai clinique couvrant d'éventuels dommages aux sujets et aux enquêteurs ;
- l'engagement du Promoteur à prendre en charge les sujets victimes d'incidents/accidents liés à leur participation à l'essai clinique et pouvant survenir à moyen ou long terme ;
- Certificats GCP de tous les enquêteurs :
    i. une preuve d'inscription de l'investigateur principal et du ou des co-investigateurs nationaux auprès d'un organisme professionnel statutaire tel que l'ordre des médecins ou l'ordre des pharmaciens (le cas échéant) ;
    ii. un justificatif de résidence au Cameroun du chercheur principal national ;
    iii. le budget détaillé de l'essai clinique, les sources de financement et l'adresse complète du promoteur et du sponsor du projet ;
    iv. l'habilitation éthique délivrée par le CNERSH en cas de procédure séquentielle ;
    v. la liste, les termes de référence et le curriculum vitae des membres du Comité de Surveillance de la Sécurité des Données ;
    vi. lorsque la recherche est multicentrique ou lorsqu'elle prévoit un transfert de données ou de matériel de recherche biologique entre l'établissement émetteur et l'établissement destinataire hors du Cameroun, les documents suivants seront également exigés :

✓ l'accord de transfert de données (Data Sharing Agreement) ;

- ✓ le contrat de transfert de matériel (Contrat de transfert de matériel).

(11) Toute modification substantielle des documents d'un essai clinique, les termes de cet essai et/ou le produit de recherche ayant reçu une autorisation éthique et une Autorisation Administrative de Recherche constitue une modification. Elle doit être remise par l'investigateur principal au CNERSH et au Ministère en charge de la Santé Publique avec les frais exigibles pour l'évaluation.

(12) En cas de situation d'urgence sanitaire comprenant des catastrophes naturelles ou accidentelles, des épidémies et des crises humanitaires, le Ministère chargé de la Santé Publique peut :

•appliquer une procédure accélérée ou d'urgence pour l'évaluation et l'autorisation des essais cliniques ;

• accorder des dérogations pour certains éléments constitutifs du dossier de demande d'essai clinique.

Section 3 : Exigences particulières

Des exigences particulières concernent les essais cliniques menés :

i. dans des situations d'urgence médicale ;
ii. sur des questions mineures ;
iii. sur les adultes incapables;
iv. sur les personnes qui ont perdu la capacité de discernement après consentement ;
v. sur la femme enceinte, l'embryon ou le fœtus in vivo ;
vi. sur l'embryon in vitro.

(1) Essais cliniques réalisés dans des situations d'urgence médicale

• Les essais cliniques en situation d'urgence médicale seront évalués par le comité d'éthique compétent et supervisés par le Ministère de la Santé Publique. Cela dépendra de chaque essai clinique et du type de produit de recherche concerné.

• Dans une situation d'urgence médicale où le consentement éclairé ne peut être obtenu avant la participation du sujet à l'essai, le traitement expérimental peut être démarré immédiatement sur le sujet si les données scientifiques et médicales disponibles indiquent que le produit expérimental peut être utilisé pour sauver la vie du sujet. le participant à l'essai, restaurer sa santé ou soulager ses souffrances.

• Le consentement éclairé du participant ou de son représentant légal sera obtenu dans les plus brefs délais et selon les délais définis par le CNERSH.

- De plus, les conditions suivantes doivent être remplies [4] :

  i. la personne concernée n'exprime pas de manière identifiable, verbalement ou par un comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche ;
  ii. un médecin non associé au projet de recherche sera consulté avant l'inclusion d'un sujet dans l'étude afin de défendre les intérêts du participant potentiel ;
  iii. les risques et contraintes inhérents à l'essai clinique sont minimes ;
  iv. les résultats attendus de l'essai clinique pourraient apporter un bénéfice à long terme aux personnes atteintes de la même maladie ou du même trouble, ou dont l'état de santé est comparable.

(2) Essais cliniques réalisés sur des mineurs

- Dans une situation de recherche impliquant des sujets mineurs (âgés de moins de 21 ans) [16], souffrant d'une maladie pouvant être soignée par le produit de la recherche, les parents ou tuteurs légaux du sujet doivent être informés de la nature, de l'importance et des implications de l'essai clinique et doivent donner leur autorisation par un consentement éclairé, écrit et volontaire. Dans le cas des mineurs (entre 12 et moins de 21 ans),

l'accord est également requis. Cette autorisation peut être révoquée sans préjudice à tout moment oralement ou par écrit par le tuteur légal ou le parent, qui décidera si nous pouvons continuer à utiliser les données collectées lors de l'essai.

- L'utilisation du produit de la recherche est conforme aux découvertes scientifiques et médicales et a pour objectifs de : sauver la vie du mineur
- concerné, rétablir sa santé, soulager ses souffrances ou prévenir une maladie.
- L'essai clinique doit bénéficier directement au groupe de patients souffrant de la même maladie que le mineur concerné.
- La recherche doit être absolument nécessaire pour confirmer les données obtenues lors d'essais cliniques sur d'autres personnes ou par d'autres méthodes de recherche.
- L'essai clinique doit porter sur une affection clinique dont souffre ou pourrait souffrir le mineur concerné.
- La participation du mineur à l'essai clinique ne peut entraîner pour lui qu'un risque et une charge minimes, qui seront évalués par le comité d'éthique compétent en fonction de chaque essai clinique et du type de produit de recherche.

(3) Essais cliniques réalisés sur un majeur incapable

Dans une situation où le sujet potentiel participant à l'essai est un adulte incapable de comprendre les enjeux de sa participation à l'essai clinique et de donner son consentement volontairement et de manière éclairée :

- l'utilisation du produit de recherche ne peut être justifiée que sur la base de données scientifiques et médicales actuelles et valides et vise à sauver la vie du participant à l'essai et à rétablir sa santé ou à soulager ses souffrances ;
- ledit essai doit être directement lié et axé sur une condition clinique potentiellement mortelle ou significativement débilitante dont souffre le

participant à l'essai, et il ne doit impliquer qu'un risque prévisible limité pour le participant ;

- les risques encourus par le participant à l'essai doivent être spécifiquement définis dans le protocole d'essai et surveillés en permanence par l'investigateur ;
- l'essai clinique ne peut être mené que s'il peut être attendu et justifié que les avantages de l'utilisation du produit expérimental pour le participant à l'essai l'emportent sur les risques encourus ;
- le consentement est donné par le représentant légal du participant potentiel après avoir été dûment informé conformément aux exigences générales définies à la section 2 du chapitre II ;
- ledit essai clinique doit être absolument nécessaire pour confirmer les données obtenues à partir d'essais cliniques menés sur des personnes capables de donner un consentement éclairé ou par d'autres méthodes de recherche ;
- A l'exception d'une indemnisation adéquate, aucun avantage particulier ne peut être accordé au participant à l'essai ou à son représentant légal.

de discernement, l'essai clinique peut se poursuivre sauf si une demande de retrait du participant de l'essai clinique est exprimée par son représentant légal, ou par le participant lui-même lorsqu'il a recouvré sa capacité.

(5) Essais cliniques réalisés sur des femmes enceintes, sur l'embryon ou sur le fœtus in vivo

- Dans le cas d'un essai clinique impliquant une femme enceinte, un embryon ou un fœtus in vivo, les exigences suivantes doivent être respectées : le rapport entre les risques prévisibles et les contraintes pour la femme enceinte, l'embryon ou le fœtus in vivo sur d'une part, et le bénéfice attendu d'autre part, ne sont pas jugés disproportionnés par le CNERSH ; les risques et contraintes inhérents au projet sont minimes pour l'embryon ou le fœtus in vivo ;

- le projet permet d'espérer des résultats essentiels qui pourraient apporter un bénéfice à long terme à d'autres femmes enceintes ou à d'autres embryons ou fœtus in vivo.

(6) Essais cliniques réalisés sur l'embryon in vitro

En cas d'essai clinique sur un embryon in vitro, les exigences suivantes doivent être respectées :

- le consentement préalable des deux (02) membres du couple ou du membre survivant du couple dont sont issus les embryons est nécessaire, ce consentement est révocable à tout moment et sans motif par l'un des deux parents tant que le les recherches ne sont pas terminées. commencé;
- les embryons utilisés dans le projet de recherche doivent être conçus in vitro dans le cadre de la procréation médicalement assistée et ne plus faire l'objet d'un projet parental ;
- le couple parental ou le membre survivant du couple doit être informé de la nature des recherches envisagées afin de leur permettre de donner leur consentement libre et éclairé.

Section 4 : Qualifications des enquêteurs

(1) Le chercheur principal est responsable de la conduite de l'essai clinique. Il doit résider au Cameroun et doit avoir une éducation, une formation et des qualifications appropriées en matière d'éthique et de sciences, notamment des médecins de toutes spécialités, des pharmaciens et des médecins bucco-dentaires.

(2) Les chercheurs fondamentaux et le personnel paramédical, selon le domaine de l'essai clinique, peuvent être regroupés pour former l'équipe multidisciplinaire.

(3) Le chercheur principal doit avoir une formation et des qualifications appropriées en éthique et en sciences.

(4) Les essais cliniques impliquant des patients ou des volontaires sains nécessitent la supervision d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé qualifié et compétent.

(5) Tous les enquêteurs impliqués dans un essai clinique ainsi que le moniteur de l'essai doivent avoir une formation officielle et documentée en Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) datant de moins de deux ans.

Section 5 : Produit de recherche

(1) Les produits de recherche (y compris les comparateurs actifs et le placebo le cas échéant) destinés aux essais cliniques doivent être fabriqués conformément aux principes de bonnes pratiques de fabrication (BPF) internationalement reconnus [17].

(2) Tous les documents relatifs aux bonnes pratiques de fabrication doivent être soumis par le promoteur ou le chercheur principal à l'autorité compétente.

(3) Tout médicament expérimental doit être soumis à un contrôle de qualité par un laboratoire national de contrôle de qualité pharmaceutique, public ou privé, agréé par l'autorité compétente.

(4) Le laboratoire qui effectue le contrôle de qualité du médicament expérimental doit être indépendant du fabricant.

(5) Le contrôle qualité doit prendre en compte d'une part les éléments de la documentation GMP, et d'autre part le respect des spécifications du produit fini et l'examen de l'emballage final.

(6) Les produits de recherche destinés aux essais cliniques doivent être correctement étiquetés et l'emballage doit identifier de manière suffisante :

- l'essai clinique concerné ;
- le(s) médicament(s) à utiliser ;
- le numéro d'identification du participant à l'essai à qui le médicament doit être administré ;

- le nom et l'adresse du site où se déroule l'essai clinique ;
- des instructions sur la façon dont ce médicament doit être utilisé ;
- la date d'émission, le cas échéant ;
- conditions de stockage;
- la date d'expiration ou d'expiration, selon le cas ;
- le numéro de référence, le cas échéant ; Et
- toute autre information requise par le Ministère chargé de la Santé Publique.

(7) Tout produit de recherche expérimentale doit bénéficier d'une Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) délivrée par le Ministère de la Santé Publique avant toute utilisation sur les participants à l'essai. La demande d'ATU de produits de recherche adressée au Ministre chargé de la Santé Publique comprend les éléments suivants :

- l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation/exemption spéciale d'importation délivrée le cas échéant ;
- des échantillons en nombre suffisant selon les procédures du laboratoire de contrôle qualité pharmaceutique agréé ;
- le certificat d'analyse des échantillons délivré par le fabricant ;
- le dossier de fabrication du produit ;
- le protocole de recherche des essais cliniques ;
- les frais à payer pour le contrôle qualité.

(8) Lorsque le produit de la recherche doit être importé sur le territoire camerounais, l'investigateur principal est soumis à la demande soit d'une autorisation d'importation si le médicament dispose d'une autorisation de mise sur le marché au Cameroun, soit d'une dérogation particulière à l'importation. sinon. Ladite demande adressée au Ministre chargé de la Santé Publique comprend les éléments suivants :

- la lettre de demande timbrée adressée au Ministre chargé de la Santé Publique, précisant les motifs de l'importation du médicament ;

- le bordereau d'expédition des produits signé par le pharmacien précisant la quantité totale, le numéro de lot et les dates de péremption des produits, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
- l'autorisation d'exploitation ou l'autorisation d'ouverture du fabricant ;
- le certificat GMP ;
- le certificat de vente libre ;
- la copie de l'autorisation de mise sur le marché du médicament dans les autres pays ainsi que le dernier rapport périodique actualisé de sécurité ou des documents équivalents le cas échéant ;
- le résumé des caractéristiques du produit ;
- des maquettes des étiquettes des contenants primaires et secondaires ;
- le protocole de recherche ;
- Autorisation administrative de recherche ;
- autorisation éthique.

(9) Les opérations de destruction des produits de la recherche doivent être documentées selon les règles du Guide national pour la gestion et la destruction des médicaments [18].

(10) Si avant, pendant ou après un essai, le promoteur/promoteur-investigateur souhaite exporter le produit de la recherche, ce dernier doit obtenir une autorisation d'exportation auprès du Ministère en charge de la Santé Publique [19].

Section 6 : Gestion des échantillons biologiques

(1) Le promoteur ou son représentant légal, le promoteur-investigateur ou l'investigateur principal est tenu de justifier de l'expertise et de la capacité technique nécessaire à l'analyse des échantillons biologiques collectés lors des essais cliniques au Cameroun.

(2) Le promoteur ou son représentant légal, le promoteur-investigateur ou l'investigateur principal est tenu de faire appel à l'expertise camerounaise pour l'analyse des échantillons biologiques.

(3) Dans les cas exceptionnels où il est nécessaire d'exporter les échantillons biologiques hors du Cameroun :

- Un accord de transfert de matériel dûment signé par un ou plusieurs instituts de recherche au Cameroun et à l'étranger doit être fourni au ministère en charge de la santé publique par le chercheur principal. L'accord précisera les conditions de transfert, de stockage, de partage, d'utilisation et de destruction éventuelle des échantillons et produits dérivés.
- Le chercheur principal doit obtenir une autorisation d'exportation de l'autorité de santé publique compétente justifiant la nécessité du transfert de matériel.
- Le promoteur ou son représentant légal doit soumettre des rapports au ministère chargé de la santé concernant les analyses du matériel biologique exporté hors du Cameroun, y compris les éventuelles publications scientifiques.

Section 7 : Modèles d'évaluation des protocoles d'essais cliniques

(1) Suite au dépôt du dossier de demande d'Autorisation Administrative de Recherche (AAR) :

La Délégation Régionale de Santé doit informer par écrit l'investigateur principal de la complétude ou de l'irrecevabilité administrative de son dossier de candidature dans un délai de 72 heures ouvrées à compter de la réception de la demande d'essai clinique par la Délégation Régionale de Santé. demande dans les 72 heures ouvrables à compter de la réception de la demande d'essai clinique par le DROS ;

- une fois avisé, le chercheur principal dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour compléter son dossier ;
- Le DROS dispose d'un délai de 21 jours [20] pour évaluer le dossier de demande d'AAR d'essai clinique à compter de la date de dépôt d'un dossier

complet. Cette durée exclut le temps mis par le chercheur principal pour répondre aux questions du DROS ;

- lors de l'évaluation administrative, si des modifications doivent être apportées aux éléments du dossier de candidature, le chercheur principal dispose d'un délai maximum de 30 jours ouvrables pour le faire. Passé ce délai, la demande est considérée comme irrecevable.

(2) Le DROS peut, lors de l'évaluation d'une demande d'essai clinique, reconnaître et/ou utiliser des décisions, rapports ou informations qu'il juge pertinents émanant d'autres autorités de réglementation nationales ou d'organismes régionaux ou internationaux.

(3) Le DROS peut créer des comités consultatifs d'experts pour l'examen des demandes d'autorisation administrative d'essais cliniques et pour toute autre question soulevée après l'approbation de l'essai.

(4) Tous les essais cliniques menés au Cameroun doivent être enregistrés dans une base de données publique locale et/ou internationale (PACTR [2] au minimum) par le promoteur/promoteur-investigateur et inscrits par les services compétents dans les registres du Comité National d'Ethique de la Recherche pour Santé humaine et ministère de la Santé publique gérés par le DROS.

(5) La liste des demandes d'essais cliniques approuvées ou rejetées ainsi que le résumé des rapports d'évaluation et le statut des essais cliniques approuvés doivent être accessibles au public et mis à jour périodiquement par le DROS.

(6) Une fois contacté par le promoteur/promoteur-enquêteur, le Comité d'Éthique dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'habilitation éthique, pour prendre une décision. Toutefois, en cas d'urgence sanitaire, ledit délai pourra être réduit à quinze (15) jours.

(7) Les lettres d'information émanant de l'évaluation du protocole de recherche sont notifiées à l'investigateur principal par la Commission Nationale d'Ethique et

le Ministère en charge de la Santé Publique contenues dans le Guide intitulé « Organisation, fonctionnement et procédures du système éthique et administratif ». évaluation de la recherche en santé humaine au Cameroun.

(8) Les modèles de présentation du protocole, la brochure de l'investigateur, l'accord de transfert de matériel biologique et l'accord de partage des données de l'étude seront conformes aux normes des Bonnes Pratiques Cliniques.

(9) Les procédures d'évaluation des protocoles de recherche sont réalisées selon les modes opératoires standardisés du Comité National d'Ethique et du Ministère en charge de la Santé Publique.

Section 8 : Éléments de refus d'habilitation éthique ou d'autorisation administrative de recherche

Une demande d'autorisation éthique ou d'AAR peut faire l'objet d'un avis défavorable dans les cas suivants :

- les formalités requises ne sont pas accomplies (voir sections 2, 3, 4 et 5 du chapitre II ci-dessus) ;
- les services compétents du Ministère chargé de la Santé Publique sont en possession d'informations indiquant que le site d'essai, l'approche méthodologique, le produit de recherche ou l'équipe de recherche ne sont pas adaptés à la conduite de l'essai clinique ;

- pour toute autre raison jugée pertinente par le Ministère de la Santé Publique et/ou le Comité d'Éthique.

Article 9 : Recours en cas d'avis défavorable

Le promoteur ou son représentant légal peut contester une décision défavorable rendue par le CNERSH ou le Ministère de la Santé Publique. A cet effet, le promoteur ou son représentant légal doit s'adresser à l'autorité compétente (Président du CNERSH/Ministre chargé de la Santé Publique) dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de la décision contestée. L'autorité compétente doit répondre au chercheur principal dans les soixante (60) jours à compter de la date de saisine.

Section 10 : Surveillance et inspection des essais cliniques

(l) Tous les essais cliniques approuvés doivent faire l'objet d'une surveillance passive et d'une activité continue à partir de la date d'approbation jusqu'à la fin de la recherche.

(3) A la suite d'une mission de suivi et/ou d'inspection par les services compétents du Ministère chargé de la Santé Publique, les mesures suivantes peuvent être prises :

- avis favorable à la poursuite de l'essai clinique ;
- demande d'amélioration d'une ou plusieurs procédures de conduite de l'essai clinique dans un délai précis ;
- demande d'informations complémentaires;
- application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

(4) L'enquêteur principal sera informé par écrit des mesures prises à la fin de la mission de suivi et/ou d'inspection.

(5) Un rapport de surveillance (DROS, CNERSH, DPML) ou d'inspection (IGSPL) est adressé au Ministre chargé de la Santé Publique dans les 7 jours suivant la mission.

Section 11 : Déclaration des effets indésirables des produits de santé

Lors de la mise en œuvre de l'essai clinique, l'investigateur est tenu de notifier systématiquement tous les événements indésirables survenant chez les participants au CNERSH, au DROS et à la DPML.

(1) Avant le début de l'essai clinique, le chercheur principal est tenu de soumettre une copie de l'AAR et de l'autorisation éthique à la DPML.

(2) Les effets indésirables graves sont signalés immédiatement (dans les 24 heures suivant la survenance de l'événement).

(3) Les effets indésirables mineurs sont signalés dans les plus brefs délais.

(4) L'acheminement des formulaires de déclaration d'effets indésirables se fait selon le circuit national de notification (District Sanitaire, Délégation Régionale de Santé Publique, Services Centraux du MINSANTE), et à l'adresse email minsantedros@yahoo.com et vigilancedpmlcmr(g)gmail.com .

Section 12 : Rapports d'essais cliniques fournis par le chercheur principal

(1) L'investigateur principal ou son représentant légal doit informer DROS par écrit de la date exacte du début de l'essai clinique (date de la première visite du premier participant inclus dans l'essai) dans les 90 jours et de la fin de l'essai clinique. l'essai clinique. essai clinique dans les 30 jours suivant la dernière visite du dernier participant.

(2) L'investigateur principal ou son représentant légal doit remettre au DROS et au CNERSH des rapports d'avancement semestriels ainsi qu'un rapport de synthèse final de l'essai clinique qui doit comprendre le certificat de destruction du produit de recherche dûment complété le cas échéant. Ce rapport doit être soumis dans l'année suivant la fin de l'essai.

(3) si l'essai est suspendu ou terminé prématurément par le promoteur ou son représentant légal, l'investigateur principal doit en communiquer la raison par écrit au DROS et au comité national d'éthique de la recherche dans les 10 jours ouvrables suivant la date de fin de l'essai clinique. .

(4) Des réunions de retour d'expérience doivent être organisées par l'investigateur principal et son représentant légal impliquant toutes les parties prenantes de l'étude, sous la coordination du DROS.

Section 13 : Exigences particulières pour les essais cliniques de médicaments traditionnels améliorés (MTA)

(1) Des essais cliniques sont requis pour les médecines traditionnelles améliorées de catégories 3 et 4. Un essai clinique peut être requis pour les médecines traditionnelles améliorées de catégorie 2 en fonction de l'évaluation de la DPML, de la DROS et/ou du CNERSH. Les données obtenues à partir de ces tests constituent un élément du dossier d'AMM.

(2) La catégorie de MTA est déterminée par la DPML selon les modalités définies par la réglementation en vigueur.

(3) Le dossier de demande d'Autorisation Administrative de Recherche pour l'essai clinique comprend les documents suivants :

- une demande timbrée au tarif en vigueur adressée au Ministre chargé de la Santé Publique ;
- un formulaire de demande d'autorisation dûment complété et signé par le chercheur principal ;
- le protocole de l'essai clinique ;
- le CV du ou des enquêteurs ;
- la note d'information du participant et le formulaire de consentement éclairé ;
- les certificats BPF du ou des sites de fabrication du médicament, le cas échéant.
- les formulaires de déclaration complétés et signés par les enquêteurs ;
- une preuve de l'approbation du comité d'éthique ;
- une preuve de paiement des frais de dossier ;
- garantir une couverture d'assurance pour les sujets et les enquêteurs (assurance institutionnelle multirisque) ;
- le budget de l'étude ;
- preuve de la disponibilité du financement pour mener l'étude.

(4) Des éléments complémentaires pouvant compléter la demande d'habilitation éthique et/ou d'autorisation administrative de recherche peuvent être exigés respectivement par le CNERSH ou le DROS.

(5) Le DROS dispose d'un délai maximum de 21 jours pour notifier la décision d'accorder, de reporter ou de refuser l'autorisation de l'essai clinique.

(6) Le DROS doit créer une commission technique multidisciplinaire d'experts pour examiner les demandes d'autorisation administrative pour les essais cliniques relatifs aux médecines traditionnelles améliorées.

(7) Les modalités de création et de fonctionnement du comité technique d'experts feront l'objet de procédures écrites élaborées par le DROS.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

DECISION N° 3498 / D/ MINSANTE/SG/DROS/DAJC DU 04 OCT 2023
rendant exécutoire les Lignes Directrices pour les Essais Cliniques au Cameroun.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé ;
Vu la loi n°2022/008 du 27 Avril 2022 relative à la recherche médicale impliquant la personne humaine au Cameroun ;
Vu le décret n°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret n° 2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;
Vu le décret n° 2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté N° 977/A/MINSANTE/SESP/SG/DROS du 18 avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Comités d'Ethique de la Recherche pour la Santé Humaine au sein des structures relevant du ministère en charge de la santé publique ;
Vu l'arrêté N° 1737/ A/MINSANTE/SG/DROS du 28 novembre 2013 fixant les modalités des frais d'évaluation des protocoles de recherche soumis aux comités d'éthique de la recherche pour la santé humaine pour l'obtention d'une clairance éthique ;

Considérant les nécessités de service,

DECIDE:

ARTICLE 1.- La présente décision rend exécutoire les lignes directrices pour les essais cliniques au Cameroun.

ARTICLE 2.- Les lignes directrices susvisées sont jointes en annexe de la présente décision.

ARTICLE 3.- Les lignes directrices pour les essais cliniques au Cameroun feront l'objet d'une actualisation en tant que de besoin, à l'initiative du Ministre chargé de la Santé Publique.

ARTICLE 4.- La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistrée puis communiquée partout où besoin sera, en français et en anglais.-/

Yaoundé, le _____

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Republic of Cameroon PAIX-TRAVAIL-PATRIE Peace-Work-Fatherland LE MINISTRE The Minister Ministry of Public Health MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,

Dr. MANAOUDA Malachie